

Trepist üles või alla. Eesti vajab tulemuslikumat kodutuse poliitikat

Jüri Kõre, Ivo Kask, Eleanora Tint

Euroopa Liit on viimastel kümnenditel pööranud varasemast suuremat tähelepanu inimeste majanduslikule toimetulekule. Muuhulgas võttis Euroopa Parlament 2011. aastal vastu resolutsiooni, milles kutsus liikmesriike üles looma eluasemepõhisel lähenemisel rajanevaid kodutusega võitlemise strateegiaid. Resolutsioon peegeldab liikmesriikides toimunud muutusi suhtumises kodutuse põhjustesse. Indiviidist sõltuvate asjaolude kõrval toonitatakse järjest sagedamini vajadust kõrvaldada ühiskonnakorraldusest tulenevad toimetulekutõkked. Muutunud on ka arusaamad kodutute rehabiliteeritavusse: hoiak „pigem mitte rehabiliteeritavad“ on asendunud hoiakuga „pigem rehabiliteeritavad“.

Eluasemepõhine lähenemine erineb otsustavalt arenenud riikides varem valitsenud käsitlusest, mille kohaselt pakutakse kodutule kõigepealt rehabilitatsiooni, ja alles seejärel omaette eluaset. Eluasemepõhine lähenemine lähtub põhimõttest: enne eluase ja siis (tegelikult samal ajal) rehabilitatsioon. Rakendatuna suurimate kodutute gruppide hulgas (psüühiliste, alkoholi- ja narko- vms probleemidega üksikud mehed) on lähenemine jõudnud Põhja-Ameerika, Austraalia ja Euroopa riikide sotsiaaltöösse.

Eestis ei ole kodutuse teema päevakorda tõusnud. Ka „Heaolu arengukava 2016–2023“ (2016) pöörab eluasemeprobleemidele vähem tähelepanu, kui talle raamistikuks olev Euroopa Liidu strateegia „Euroopa 2020“ (2010), ega paku ideid ühiskonna kõige vaesema osa sotsiaalseks tõusuks.

Artiklis otsitakse vastust küsimusele, kas jätkata Eestis selles valdkonnas tööd traditsioonilisel moel või juurutada innovaatilisi lahendusi. Selleks kirjeldatakse viimasel kümnendil kodutuses toimunud muutusi Eestis ning antakse ülevaade kahest vastanduvast lähenemisest kodutute rehabilitatsioonile: astmelise rehabilitatsiooni mudelist ja eluasemepõhisest lähenemisest. Analüüsides ühe traditsioonilise teenuseosutaja tegevuse tulemuslikkust ja Eesti asjatundjate hinnanguid eluasemepõhisele teenuse mudelile jõutakse järeldusele, et praegune praktika töös kodututega tuleb üle vaadata.

Sissejuhatus

Allkirjastades 2003. aastal Euroopa Liidu (EL) sotsiaalse kaasatuse memorandumi, liitus Eesti Lissaboni strateegiaga. Selle algatuse eesmärk oli parandada ühendusse kuuluvate riikide globaalset konkurentsivõimet, panustades

teadus-arendustegevusse, tööturgu, inimeste majanduslikku toimetulekusse ja sotsiaalsesse ühtekuuluvusse. Jooksvaks kümnendiks kokku lepitud „Euroopa 2020“ nimetust kandev strateegia pöörab vaesusele ja tõrjutusele endiselt suurt tähelepanu (Euroopa Komisjon

2011). Kõige üldisemad soovitud sotsiaalteenuste tänapäevaseks korralduseks leiduvad Euroopa ühtsetes juhistes institutsionaalselt hoolduselt kogukonnapõhisele süsteemile ülemineku kohta (Institutsionaalselt hooldusmudelilt ... 2012). Euroopa Parlament, järgides oma deklaratsioone tänavakodutuse lõpetamise (2008) ja EL kodutuse strateegia (2010) kohta, kutsus oma 2011. aasta resolutsioonis liikmesriike üles looma kodutusega võitlemise strateegiaid, mis keskenduksid eluasemepõhisele lähenemisele.

Mitmes Euroopa riigis on Põhja-Ameerika ja Austraalia eeskujul põhimõtteline muutus kodutute teenusekorralduses juba toimunud: asutushooldust on kärbitud kogukonnanhoolduse kasuks¹. Varasema järk-järgulise (astmelise) resotsialiseerimise mudeli (ingl *housing ready*) asemel on töös kodututega kasutusele võetud eluasemepõhised (ingl *housing first*) mudelid.

Eluasemepõhised kodutute resotsialiseerimise mudelid toetuvad kahele põhimõttele: esiteks tuleb raskustesse sattunud isikule kiiresti leida omaette eluruum; teiseks peab olema mõjus teenuste ja toetuste süsteem tema sotsiaal-, tervise-, hõive- jm probleemide lahendamiseks.

Käesoleval hetkel püütakse Eesti arengut suunata 53 riikliku strateegilise dokumendiga, millest enamik on sotsiaalse arengu mõjutamise vaatenurgast lühiajalised ja kavandatud 2020. aastani. Ilmselt pole Eestis kõrgetasemelist dokumenti kodutuse strateegia näol suhteliselt kitsa probleemi lahendamiseks vaja. Paraku ei käsitleta seda teemat ka „Heaolu arengukavas 2016–2023”, mis pakub formaalse raamistiku vaesusega võitlemiseks, kuid eluaseme kättesaadavuse suurendamine sotsiaalsete probleemidega inimestele on jäänud arengukavast välja.

EL strateegia „Euroopa 2020” kontekstis on Eesti võtnud küll vaesuse vähendamiseks konkreetse eesmärgi: vähendada vaesusriskis ja tõrjutuses isikute suhtarvu 2010. aasta 17,5%lt 15%ni 2020. aastal, kuid taotlemata kodutuse kui vaesuse äärmusliku vormi vähendamist on sotsiaaltöö seisukohast raske pidada seda strateegilist eesmärki piisavalt ambitsioonikaks.

Analüüsida tuleks ka kodutute resotsialiseerimise praktika efektiivsust: Eesti suuremates linnades on valdavalt kasutusel astmelise rehabilitatsiooni mudel, mis näeb ette inimeste järg-järgulist liikumist rehabilitatsiooni toel üha suurema iseseisvusega eluasemevormi suunas, kuid vaid vähestel õnnestub jõuda n-ö esimestest astmetest kõrgemale.

Artiklis analüüsitakse ühe Eesti teenuseosutaja 2014. aasta tegevuse näitel praeguse astmelise rehabilitatsiooni korralduse tõhusust ning esitatakse meie asjatundjate hinnangud eluasemepõhisele mudelile. Artikli eesmärk on õhutada teiste riikide kodutute rehabiliteerimise edulugusid tutvustades astuma ka Eestis samme sotsiaaltöö tulemuslikkuse suurendamiseks. Et seda saavutada, tuleks teha emba-kumba: kas sooritada hüpe praeguse mudeli tulemuslikkuses või asendada see teistsuguse, tõendus põhisel tõhusa eluasemepõhise lähenemisega.

Kodutus Eestis: teooria ja praktika

Kodutuse mõiste ja kodutute arv Eestis

Kodutu määramine tundub lihtne: see on kindla elukohata isik. Sellegipoolest puudub mõistel üldtunnustatud ametlik definitsioon. Mõiste kodutu alla võivad mahtuda nii isikud, kellel elukoht täielikult puudub, kui ka need, kellel hetkeolukorrast tulenevalt (perevägivald, isikute vaheline konflikt, ahistamine

¹ Näide Soomest: Päästearmee 500kohaline öömaja Allpikatu Helsingis on muudetud 80 korteriga eluasemepõhiseks teenuseüksuseks (Pleace jt 2015, 60).

vms) ei ole võimalik oma tavaeluruumis viibida.

Euroopa riikides on laialt kasutusel 2005. aastal välja töötatud ETHOS tüpoloogia² (2006), mis jaotab kodutud kui kategooria järgmisteks allkategooriateks:

- **Peavarjuta isik:** inimene, kes elab tänaval või kasutab ajutist varjupaigateenust.
- **Koduta inimene** (ingl *houseless*): inimene, kes kasutab mõne sotsiaalmajutusasutuse, varjupaiga vm institutsiooni võimalusi.
- **Isik, kellel pole eluruumi kasutamiseks juriidilist kaitset:** inimene, kelle eluase on ebakindel, kuna see ei kuulu talle; keda ohustab väljatõstmine või perevägivald.
- **Ebakvaliteetset eluruumi kasutav isik:** inimene, kes elab ajutises, selleks mitte ettenähtud kohas, elamiskõlbatutes ruumides või ülerahvastatuse tingimustes.

Sõltuvalt definitsioonist ja tegelikust elamissituatsioonist ning poliitikast, on kodutuse näitajad riigiti väga erinevad. OECD poolt rahvuslike allikate põhjal tehtud koondi järgi on täisealisest elanikkonnast kodutuid 0,1% (Jaapan) kuni 5,6% (Rootsi). Siinkohal on oluline märkida, et Rootsi definitsioon on laiaulatuslik ja käsitleb kodututena ETHOSe kõigi nelja kategooria isikuid (OECD 2015).

Mitmes varasemas uurimuses (Kõre 2003, Kõre jt 2006) tunnistati Eesti olude jaoks sobivaks rootslase Hans Swärdi definitsioon: „Kodutu on inimene, kellel puudub isiklik või üüritud eluase, alalised majutustingimused ning kes on suunatud ajutistesse alternatiiv-eluasemetesse või ööbib väljas” (1999). Swärdi üldistusaste haarab ETHOSe klassifikatsiooni

kahte esimest gruppi ja seda võib pidada Eesti jaoks endiselt sobivaks³.

Kui palju on aga Eestis kodutuid? Tabel 1 (lk 42) koondab eri allikatest pärinevad andmed. Tallinnas loendati 2010/11. a vahetusel kodutud üle kahel korral: rahvaloendusel ja Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse kodutute loendusel. Tulenevalt loenduse korralduse ja kodutuse definitsiooni erinevusest erines loenduste tulemus kahekordselt. Praktilise poliitika kavandamiseks võib pidada sobivaks Tallinna linna kodutuse käsitlust. Eesti kodutute arvu puhul võtame aluseks Tallinna loenduse ning 2002. a eksperthinnangus ja 2011. a rahvaloendusel fikseeritud Tallinna ja Eesti proportsiooni (Tallinna osakaal Eesti kodutute arvust oli vastavalt 57–65% ja 65%). Kodutute hinnanguliseks arvuks Eestis kujuneb 1900–2100 inimest ehk 1,5%. On üsna tavaline, et otseste loendusandmete puudumisel või kahtluse korral nende õigsuses kirjeldatakse kodutuse dünaamikat öömajade ja varjupaikade klientuuri dünaamika alusel. Aastatel 2004–2014 pole selle kliendigrupi puhul langustendentsi näha: 2004. aastal 2301 inimest, 2014. aastal 2551, perioodi keskmine 2344. Seega on põhimõtteliselt võimalik väita, et kodutute arv Eestis on eelnenud arvutuses saadud arvust suurem (2300–2500 inimest).

Kõnekamad uuringud ja artiklid kodutuse kohta Eestis 2004–2014

Sotsiaalsete probleemide pingereas on kodutus suhteliselt tagaplaanil kõigis Balti riikides (Kõre ja Karpuškiené 2009). See ei soodusta teema uurimist ja uusi käsitlusi valdkonna

² ETHOS (*European Typology on Homelessness and Housing Exclusion*) – Euroopa kodutuse ja eluasemepuuduses isikute tüpoloogia.

³ Kodutuse definitsiooni laiendamine Eestis on küsitav, kuna puuduvad nii andmed kui ka avaliku sektori sisuline võime suuremamahuliseks sekkumiseks eluasemeturgu. Bush-Geertsema jt (2014) analüüsi järgi on ainult viiel EL liikmesriigil andmeid kodutute ja eluasemepuuduses isikute kohta ETHOSe klassifikatsiooni kõigi allkategooriate ulatuses.

Tabel 1. Hinnangud kodutute arvule Eestis ja Tallinnas

	2000. a rahva-loendus	2002. a majandus- ja sotsiaal-ministeeriumi hinnang	2002. a KOV sotsiaal-töötajate ekspert hinnang	2010/2011. a Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse loendus	2011. a rahva-loendus	Kodutute oomaja ja varjupaiga teenuse kasuta-jate statistika 2004–2014
Eesti	369	5000	3000–3500		864	Vahemikus 2004. a 2301–2014. a 2551, keskmine 2344
Tallinn			2000	1225	558	

ALLIKAS: TALLINNA SOTSIAALTÖÖ KESKUS 2012; KÕRE 2003; TIIT 2013; SOTSIAALMINISTEERIUM 2016A, 2016B; STATISTIKAAMET: RAHVA JA ELURUUMIDE LOENDUS 2011

kohta lisandub vähe. Üheks vaadeldava perioodi huvitavamaks uurimuseks on Signe Dobelnice (2007) Tallinna Ülikoolis kaitstud doktoritöö „Kodutus Lätis: põhjused ja lahendused”. Tavalise kodutuse individuaalsete ja struktuursete põhjuste analüüsi kõrval pälvib tähelepanu töös käsitletud vaesuskultuuri teooria (vt Lewis 1966). Autor järeldeb, et Läti kodututel on tekkinud oma subkultuur, mis ühelt poolt toetab nende toimetulekut oma eluviisi ja grupi raames, teisalt aga takistab resotsialiseerimist. Seda tulemust ei saa automaatselt Eesti oludesse üle kanda, kuid vaesuskultuuri fenomen on kindlasti võimalik ka Eestis.

Ülevaatliku pildi Tallinna kodutute resotsialiseerimise korraldusest saame ajakirja Sotsiaaltöö 2010. aasta neljanda numbriga tutvudes (vt Eesmet 2010, Põldmaa 2010).

Tegu on astmelise, nelja liiki teenustel baseeruva süsteemiga: vältimatu sotsiaalabi teenus, vältimatu abi järgne püsihooldust pakkuv teenus, resotsialiseerivad teenused ja preventiivse iseloomuga teenused. Seni välja arendamata teenusena nimetatakse artiklis täielikult toimetulematute ja resotsialiseerimatute teenust⁴.

Erialainimeste seas kõige laiemalt levikuga artikkel on ilmselt Lilya Wagneri, Erki Korpi ja Charles Waltersi „Homelessness in Estonia: Overview and Analysis” (2014). Artikli lühikokkuvõte lubab bravuurikalt esitada „... anekdootlikud tõendid kodutuse kohta Eestis nõukogude ajal ja üleminekuperioodil ning kirjeldada põhjalikult tänast situatsiooni” (2014, 231). Eesti olukorra tundjale on artiklis uut infot vähe, olulisimad on andmed resotsialiseerimise tulemuslikkuse kohta pealinnas.

⁴ Teistes suuremates linnades, näiteks Tartus ja Pärnus, kehtib ühe asutuse põhine astmelise rehabilitatsiooni mudel. Väiksemates omavalitsustes pakutakse eelkõige vältimatu abi teenust kombineerituna juhtumipõhise eluasemeprobleemide lahendamisega.

Kirjeldatavat tulemit (2013. a resotsialiseeriti 20–25 isikut) on aga keeruline hinnata, sest kaotsi on läinud teenusekasutajate üldine arv.

Kümnendi kaalukamad rakendusuurinud on Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse (2012) kodutute loendus ja sama asutuse korraldatud klientide rehabiliteeritavuse hindamine (kolm aruannet: 2010, 2012, 2014). Esimeses töös konstateeritakse, et võrreldes Jüri Kõre 2003. a artiklis nimetatutega ei ole kodutuse põhjused kümne aastaga muutunud. Loendusega võrdset tähelepanu väärrib rehabiliteeritavuse hindamise metoodika (PPS-1 ja PPS-2 skaalad) juurutamine keskuse poolt. PPS-1 skaala on Eestis küll aastaid tuttav, kuid pole laiemalt kasutatud (vt Paavel 2003). Uuringute tulemusena lükatakse ümber laialt levinud arvamus kodutute vähesest rehabiliteeritavusest. Kui Kaarel Talvoja 2007. aastal kaitsnud bakalaureusetööst leiame eksperdi arvamuse, et rehabiliteeritavad on vaid 5% öömaja, 45% varjupaiga ja 80% sotsiaalmajutusüksuse klientidest, siis 2010. aasta hindamise kohaselt olid rehabiliteeritavad või pigem rehabiliteeritavad 76%, 2012. aastal 72% ja 2014. aastal 82% isikutest.

Kodututele suunatud teenusemodelid

OECD uuring (2015) eristab nelja kodututele suunatud kompleksset (integreeritud) teenuste osutamise mudelit: vältimatu abi teenused (tänavatöö, toitlustamisvõimalus, öömaja, päevakeskus); püsiva toetusega eluasemeteenus (üldjuhul eakatele inimestele, tööelastele osutatakse koos kaitsstud või toetatud töö teenusega); eluasemepõhine üleminekuteenus ja eluasemepõhine teenus koos vastava mobiilse või statsionaarse juhtumikorraldusega (kombineeritud eluaseme-, tervishoiu-, sotsiaal- ja teatud juhtudel tööturuteenused). Refereeritav uuring käsitleb neid võrdsetena, kuid sisuliselt on tegu mudelite hierarhiaga: esimese mudeli puhul on teenuste eesmärgiks

kergendada „tänavaelaniku” elu, neljanda puhul tõkestada tavaeluruumis elava isiku tagasilangust.

Viimastel aastatel on hakatud sagedamini rääkima hoopis traditsioonilise (astmelise) ja innovaatilise (eluasemepõhise kompleksse) rehabilitatsiooni mudelist. Nende kahe kontseptsiooni eristamine ja sotsiaaltöö praktikas toimuv nihe teisenä nimetatu kasuks tähendab ka rõhuasetuse muutust kodutuse põhjuste käsitlemisel.

Astmelise rehabilitatsiooni mudel

Astmelise rehabilitatsiooni mudel rõhutab individuaalsete tegurite rolli ja põhineb indiviidi järk-järgulisel liikumisel ühest rehabilitatsiooni etapist (eluaseme vormist) teise. Sellega kaasneb personaalse vabaduse ja vastutuse määra kasv on omamoodi „preemia hea käitumise eest”. Noémie Houard (2011) kirjeldab nn trepimudelit kui kodutu sihi-kindlat arengut, mille tulemusena ta saab endale püsielukoha. Kuid eelnevalt peab inimene olema „sobiv” iseseisvalt eluruumi kasutama ja läbima trepi madalamad astmed. Oluline on isiku motiveeritus, tahe oma elu muuta ja iseseisvalt toime tulla (Houard 2011). Eristatakse kahte peamist astmelist teenusekorralduse vormi: ühe asutuse põhine mudel (ingl *single-site traditional service model*) ja astmelise rehabilitatsiooni mudel (ingl *staircase model*) (OECD 2015). Omadussõna „traditsiooniline” saanud probleemikäsitlus ja lahendusviis domineerisid konkurentsitu kuni 1960. aastate keskpaigani: see viie-kuue astmega trepp iseseisvasse ellu oli kodutusega võitlemise „meelisstrateegiaks”. Põhjamaades (Sahlin 2005; Tainio ja Fredriksson 2009, 185; Benjaminsen ja Dyb 2008, 57).

Tänapäeval rõhutavad nii praktikute kui teoreetikute leerist kostvad hääled kodutuse kontekstis kahesuguseid asjaolusid. Esiteks vajavad kodutud resotsialiseerimiseks

pikaajalist toetust ja trepi viimasele astmele jõudmine ei tähenda veel teekonna lõppu. Teiseks võib öelda, et seoses elukoha puudumisega päevakorda kerkivad probleemid kuuluvad tänapäeval suurel määral ühiskondlikku huvisfääri, seda eriti tervisega, sõltuvustega jms seotud probleemid (Burrows 1997, 36; Fitzpatrick jt 2016). Volker Bush-Geertsema (2008) konstateerib, et trepi alumistel astmetel on „kitsas”, sest suurem osa seltskonnast koondub sinna, ja ülemised astmed on omamoodi pudelikael, millest vähesed läbi pääsevad. Trepimudeli kasutamise korral hinnatakse resotsialiseerimise efektiivsuseks 30–50% (Pleace 2008, Rosenheck 2010 OECD 2015 kaudu). Eestis on kodutute resotsialiseerimisel valdavalt kasutusel seesama, lihtsam või keerukamas variandis astmelise rehabilitatsiooni mudel.

Fakt, et pikemaajaline elu reguleeritud-reglementeeritud-toetatud keskkonnas tekitab tavaeluga kohanemisel probleeme, on teada asenduskodu, kinnipidamisasutuse jt institutsioonide elanike ühiskonda sulandamise näidetel. Kodututele peavarju pakkuvad asutused oma suhteliselt jäikade reeglite ja indiviidi seisukohast väikese privaatsusega paigutuvad samasse loetellu. Mike Allen (2012, 121) juhib tähelepanu sellele, et käsitlus, mis on suunatud kodutuse kui probleemi haldamisele, sarnaneb eakatele suunatud teenuste mudeliga. Alternatiivse eluasemepõhise käsitluse eeskujuks on pigem töötutele suunatud poliitika, mis püüavad aidata inimest olemasolevast seisundist või situatsioonist välja.

Eluasemepõhine lähenemine

Mõiste eluasemepõhine lähenemine on Põhja-Ameerikas kodutusega tegelevate organisatsioonide esindajate kõnepruugis juba paar aastakümnet. Selle mudeli kasutuselevõttu töös kodutute „tuumikgrupiga” ehk üksikute

kodutute meestega seostatakse eelkõige Sam Tsemberise poolt USAs asutatud *Pathways Housing First* (PHF) nimelise organisatsiooniga (Tsemberis jt 2004). Organisatsiooni tegevuses eristati tinglikult kahte teenust: ühelt poolt eluasemeteenus ja teisalt näiteks alkoholisõltuvuse ravi. Ühtlasi võrreldi praktilises töös rehabilitatsiooni tõhusust astmelise ja eluasemepõhise mudelite puhul. Tulemused olid ühemõtteliselt eluasemepõhise lähenemise kasuks. Tavameetodil resotsialiseerimisteenust saanud grupi puhul oli tulemuslikkuseks 47%, PHF mudeli kasutajatel 88% (Tsemberis 2010). Umbes sama proportsiooni (kaks korda kõrgem positiivsete muutuste osakaal) fikseeriti vaimse tervise probleemidega inimeste ravis, kui eluasemeprobleem on enne ravi lahendatud (Nelson jt 2015). USA algset eluasemepõhist käsitlust kirjeldatakse järgnevalt: 1) iseseisev eluase (mitte siirdeeluruum vms); 2) püsiv üürisuhe; 3) toetus tervise- või sotsiaalprobleemidega (psüühikahäire, alkoholi-, narkosõltuvus vms) toimetulekuks; 4) loobumine resotsialiseerimiseks ettevalmistavate teenuste kasutamisest, kaasa arvatud siirdeeluasemest (Busch-Geertsema 2011). Nüüdseks on USA eeskuju levinud Kanadasse ja Austraaliasse ning 2011.–2013. a Euroopa Komisjoni poolt rahastatud projekti Housing First Europe vahendusel ka kümnesse ELi riiki (Busch-Geertsema 2013).

Soomes võeti uus mudel kasutusele seetõttu, et lahendades probleeme traditsiooniliselt, jõuti ühel hetkel n-ö klaaslaeni: vaatamata suurtele pingutustele kodutute arv enam ei vähenenud. Edasi liikumiseks oli hädavajalik teistsugune käsitlus (Tainio ja Fredriksson 2009, 188). Taani esitleb mudelit kui viimaste aastate üht tõhusamat vaesusega võitlemise programmi (*Integrated approaches to combating poverty...* 2016). Euroopa projektides on jõutud USAsarnase

tõhususe tasemeni – rehabiliteeritavus on 70–90% (Bush-Geertsema 2011, 6; Bush-Geertsema 2012, 244; Tsemberis 2012, 170). Eri sotsiaalses ja majanduslikus keskkonnas katsetatuna esitlevad mõned autorid seda käsitlust isegi tõendus põhise praktikana (Raitakari ja Juhila 2015, 146). Niisiis on eluasemepõhine lähenemine pälvinud viimastel aastatel suurt tähelepanu, kuid vastav praktika on siiski veel suhteliselt napp. Eelkõige on see tunnustatud sobivaks raskemate (üle aasta kestnud) kodutuse juhtumite lahendamisel.

Analüüsides 1990.–2014. aastal avaldatud eluasemepõhiseid probleemikäsitlusi (184 allikat), jagavad Suvi Raitakari ja Kirsi Juhila need üheksasse gruppi (võrdlevad uuringud, juhendid, raportid, jne). Refereerime siinkohal 27 raporti koondjärgeldusi: 1) saavutatav on kulude kokkuhoid ja klientide heaolu tõus, tegemist on efektiivse teega kodutusest välja; 2) mudeli tulemuslikkuse tagab püsiv ja piisav rahastus ja väljaõppinud spetsialistid; 3) efektiivse tulemuse eelduseks on eluruumide hajutamine; 4) vajalik on rehabiliteeritavate pikaajaline toetamine; 5) loobuda ei tohi lähenemise tuuma moodustavatest põhimõtetest; 6) mudel on kasutatav erinevates kogukondades olenemata nende suurusest, rahvuslikust koosseisust vm tunnustest; 7) stigmade, isolatsiooni, vaesuse, töötuse jm resotsialiseerimist takistavate tõkete ületamine ei ole võimalik ilma muudatus-teta ühiskonna tasandil (Raitakari ja Juhila 2015, 157).

Siiski tuleb välja tuua ka eluasemepõhise lähenemise puhul tekkivaid kõhklusi ja küsimusi, nagu näiteks: 1) kas USAs saavutatud edu on Euroopas korratav, 2) kas käesolev mudel on rakendatav kõigi pikaajaliselt kodutute puhul, 3) kas suur tähelepanu ühele lähenemisele ei kahjusta teiste meetodite kasutamist ja arengut (Pleace 2011; Johnsen 2012).

Eeldused eluasemepõhise lähenemise kasutamiseks Eestis

Kaks värsket uuringut

Millised on Eesti võimalused eluasemepõhise lähenemise kasutusele võtmiseks? Järgnev artikli osa on süntees kahe iseseisva, kvalitatiivsel ja kvantitatiivsel meetodil tehtud uurimuse tulemustest.

2014. aastal analüüsiti poolstruktureeritud intervjuudega eluasemepõhise lähenemise perspektiivi töös kodututega Eestis (Käsk 2014). Ekspertideks valiti praktikud kolmest suurimate Eesti omavalitsuste hulka kuuluvast linnast, kus on välja arendatud kodutute astmelise rehabilitatsiooni mudel – Tallinnast, Tartust ja Pärnust. Kõigil ekspertidel oli sotsiaaltöölane kõrgharidus ja vähemalt 8aastane praktilise töö kogemus. Intervjuu hetkel oli nende töös rõhuasetus kodutute resotsialiseerimisel. Esimene ekspert on töötanud tööealiste riskikäitumisega inimestega, intervjuerimise ajal oli ta sotsiaalse ettevõtte juhataja. Teine ekspert on töötanud psüühilise erivajadusega klientidega ja kodututega. Intervjuu hetkel töötas ta kohaliku omavalitsuse hallatava asutuse koosseisu kuulavas kodutute päevakeskuses. Kolmas ekspert on spetsialisti ja juhina täitnud mitmesuguseid ülesandeid kohalikus omavalitsuses. Intervjuu temaga tehti ajal, kui ta oli kohaliku omavalitsuse hallatava asutuse allüksuse juhataja.

Teine uuring, mis viidi läbi 2015. aastal, annab ühe teenuseosutaja tegevuse näitel teavet astmelise rehabilitatsiooni mudeli tõhususe hindamiseks ning õhutab mõtlema senise lähenemise jätkamise poolt- ja vastuargumentidele (Tint 2015). Analüüsi aluseks olev andmestik pärineb kolmest allikast: teenuseosutaja poolt igapäevatöö tarbeks kogutud info (sotsiaaldemograafilised andmed); võrgustik (pereliikmed, sugulased, sõbrad) ja selle toimimine (suhtlemise sagedus, iseloom

jne); omavalitsuse dokumendihaldussüsteemi *GoPro Case* andmed (eluaseme taotlemine, eraldamine, üürilepingu lõpetamine jne) ning sotsiaalteenuste ja toetuste andmeregistri STAR info (puude ja/või töövõimetuse olemasolu, sissetulekud, saadud teenused). Analüüsiks kasutati ainult dokumenteeritud infot, kliente dokumendiandmetes olevate lünkade täitmiseks ei küsitletud. Info salvestati ja töödeldi isikustamata kujul *SPSS Statistic* programmi abil.

Muutused kodutuses ekspertide hinnangul

Eespool tõdesime Tallinna kodutute loendusele toetudes, et tänased kodutuse põhjused sarnanevad kümne aasta tagustega (Tallinna Sotsiaaltöö Keskus 2012). Kolmes astmelise rehabilitatsiooni mudelit rakendavas omavalitsuses töötavate praktikutega tehtud intervjuudes on siiski viiteid kodutute kogukonnas toimunud muutustele. Osaliselt kajastab neid muutusi ka Tallinna kodutute loendus. Esiteks on kasvanud pikaajaliste (rohkem kui üks aasta) kodutute osakaal: 2012. aastal oli Tallinnas vaid 9,5% loendatutel vähem kui ühe aasta pikkune kodutuse staaž (Tallinna Sotsiaaltöö Keskus 2012, 21). Teiseks suureneb intervjuueeritud ekspertide hinnangute kohaselt sihtgrupi hulgas liitprobleemidega (üheaegselt sõltuvus ja vaimse tervise vm meditsiiniline probleem) isikute osakaal. Kolmandaks juhivad eksperdid tähelepanu asjaolule, et kodutute hulgas kasvab nende inimeste osatähtsus, kes ise või kelle perekond on olnud eluaseme omanik. Eluaseme kaotusel on sealjuures tihti põhiroll inimesel (perel) endal, mitte kellelgi kolmandal (laenuandja vms). Tallinna andmetel oli 24% küsitletutest enne eluaseme kaotust omanikud, 9% elasid abikaasa ja 30% sugulase või tuttava juures, endisi üüriikke oli 30% (Tallinna Sotsiaaltöö Keskus 2012, 14). Neljandaks on ajutiseks

elupaigaks mõeldud institutsioonid (öömaja, varjupaik, sotsiaalmajutusüksus) faktiliselt muutunud pikemaajalisteks elukohtadeks: hinnanguliselt jääb sinna jõudnud isikutest 85% kliendiks kauemaks kui üheks, 50% kauemaks kui kaheks aastaks. Siirdeeluaseme pikaajaline kasutamine ei toeta resotsialiseerimist, pigem suurendab tagasilanguse riski. Viiendaks suunavad spetsialistid ressursside puuduse tõttu oma tähelepanu inimestele, kes on olnud lühemat aega kodutud, lootes nende rehabiliteeritavusele, ja kuuendaks võib koduta inimesel esineda erivajadusi või probleeme, mida ei pruugi olla võimalik muuta (nt vaimupuue, aga ka alkoholi liigtarvitamine või narkosõltuvus). Sellises olukorras võib olla maksimumtulemuseks see, kui inimene suudab näiteks oma sõltuvusest tulenevaid probleeme kas iseseisvalt või toetuse abil kontrolli all hoida (Käsk 2014, 32–34).

Ühe asutuse teenusekorraldus: kuhu liikuda edasi?

Põhjamaadele iseloomulik kodutute astmelise rehabilitatsiooni mudel, mis on üles ehitatud mitme eri funktsiooniga asutusele, on Eestis välja arendatud ainult Tallinnas. Teistes omavalitsustes, kus eluasemeprobleemiga tegelemine on sotsiaalprobleemide hulgas otse või kaudselt eristatud, domineerib ühe asutuse põhine lähenemine. Järgnev ühe teenusepakkuja (varjupaiga) 2014. aasta kliendiandmete ja tegevuse analüüs annab infot arutlusteks võimaliku teenusearenduse suhtes (Tint 2015). Käsitleva teenusepakkuja osutab varjupaigateenust voodikoha kasutamisega või ilma (mööbleerimata ruum joobes isikutele öö veetmiseks), päevakeskuse teenust ning sotsiaalmajutusteenuse nime all siirdeeluaset. Sellises teenusekorralduses on üheaegselt nii trepimudeli kui ka eluasemepõhise lähenemise jooni. Sotsiaalmajutusteenust võib saada ilma eelneva teenuseastmeta, edasine tee võib sealt

viia nii alla- (varjupaika) kui ka ülespoole (sotsiaaleluruumi).

Üldvarjupaikade kliendiandmete põhjal tehakse sageli järeldus, et eluasemeprobleemiga on eelkõige üksikud, tugivõrgustikuta mehed. Käesolev uuring näitab, et antud kliendigrupist on paljudel võrgustik olemas, kuid probleemiks on, et see ei toimi. Võrgustik on tähtis resotsialiseerimist toetav ressurss. Küsimus on, kas võimalus taastada suhted võrgustiku liikmetega on suurem, kui inimest hoitakse pikka aega varjupaigas resotsialiseerivate teenuste ootel või siis, kui ta suunatakse kiiresti iseseisvust ja vastutust nõudvasse olukorda ehk omaette elamispiinnale.

Peamiseks toimetulekut takistavaks teguriks on Eesti kodututel aga hoopis alkoholisõltuvus, mida rõhutasid nii kvalitatiivuuringu käigus intervjueeritud eksperdid (Käsk 2014, 32) kui ka Tallinna kodutute loenduse läbiviijad (Tallinna Sotsiaaltöö Keskus 2012, 21); see asjaolu võib takistada eluasemepõhise lähenemise kasutuselevõttu. Teisalt kasvab vaimse tervise probleemide osakaal, mis osalt tekib alkoholisõltuvuse pinnal (Tint 2015, vt tabel 2).

Kuna psüühikahäire näol on tegemist delikaatsete isikuandmetega, mida varjupaikateenuse osutaja ei kogu ega tallata, siis teiste riikide statistika põhjal⁵ võib oletada, et vaimse tervise probleemid on sihtgrupi hulgas tõenäoliselt enam levinud, kui näitab tabel 2: väga suure osa varjupaiga klientide puhul andmed psüühikahäire või vaimupuude olemasolu kohta puuduvad. Varjupaiga klientuuri hulgas oli sissetulekuga isikute osakaal märkimisväärne (kuni 60%), kuid ainuüksi sissetuleku olemasolu ei taga iseseisvat toimetulekut, kuna vähesed neist inimestest suudavad oma kulusid kontrollida.

Asutuse 2014. aasta kliendid jaotusid aasta lõpus staatuse järgi viide gruppi (vt tabel 3, lk 48): 1) staatus pole aasta jooksul muutunud (varjupaigas, k.a sotsiaalmajutusteenuse või toetatud elamise ootel) – 42%; 2) muus institutsioonis (sotsiaalmajutus-, hooldekodu-, rehabilitatsiooni-, meditsiiniteenusel, teenuse ootejärjekorras) – 22%; 3) eluasemepõhine lahendus olukorrale (elab üüri- või sotsiaaleluruumis, on taasühinenud perekonnaga) – 14%; 4) suunatud elukohajärgsesse omavalitsusse – 10%; 5) surnud – 11%. Sellest

Tabel 2. Koduta isikute võrgustik, vaimne ja ainealine toimetulek ning sissetulek ühe varjupaiga andmete põhjal

Mitteformaalse tugivõrgustiku olemasolu	%	Mitteformaalse tugivõrgustiku toimimine	%	Psüühikahäire või vaimupuude olemasolu	%	Sissetuleku olemasolu	%
Olemas	75	Toimib	13	Tead, olemas	20	Vanadus-, töövõimetus-, rahvapension	58
Puudub	12	Ei toimi	46	Tead, pole	16	Töö	10
Teadmata	13	Teadmata	41	Teadmata	64	Sissetulekuta või teadmata	41
Kokku	100	Kokku	100	Kokku	100	Kokku	109*

*8 isikut oli üheaegselt nii tööl kui pensionil. ALLIKAS: TINT 2015

⁵ Näiteks ulatus Busch-Geertsema jt (2014, 84) andmetel 2009. aastal vaimse tervise probleemidega isikute osakaal Helsingi pealinnapiirkonna kodutute hulgas 89%ni.

arvutusest jäid välja teadmata kohas viibivad isikud ehk 1/3 aasta klientuurist. Näeme, et klientide edasiliikumine toimub pigem institutsionaalset teed pidi ja eluasemepõhise lahenduste osatähtsus (sotsiaalmajutusteenusele, sotsiaaleluruumi ootejärjekorda ja sotsiaaleluruumi ning üürielamispinnale läinud) on vaid 14%.

Faktilise resotsialiseerimise osakaal kogusummast (jättes eelnevast loetelust välja sotsiaalmajutusteenusele siirdunud ning lisades loetellu sugulaste/tuttavate

juurde läinud, kokku 10%) on liialt väike, et pidada tulemust rahuldavaks. Aasta keskmine varjupaiga klientide arv on kümne aasta keskmisena 2014. aastaga võrreldes samas suurusjärgus. Samas suurusjärgus on ka 10 (15) aasta jooksul esitatud taotlused sotsiaaleluruumile. Need kaks numbrite rida kinnitavad eespool esitatud seisukohta, et trepi alumistel astmetel on nii kitsas, et üles (omaette eluruumini) suudavad „trügida” vähesed (tabel 4). Üheaegselt selle tulemuse konstateerimisega peab paratamatult tegema

Tabel 3. Asutuses 2014. aasta jooksul varjupaigateenust kasutanud isikute staatus aasta lõpul

Varjupaigast läinud ...	Teenuse- kasutajate arv aasta jooksul	% kõigist teenuse kasutajatest	Isikute arv, kelle staatus 2014. a lõpus oli teada	% isikutest, kelle staatus 2014. a lõpus oli teada
üürielamispinnale	6	2,8	6	4,3
sugulaste/tuttavate juurde	4	2,0	4	2,9
sotsiaaleluruumi	10	4,7	10	7,2
sotsiaaleluruumi ja toetatud elamise tee- nuse ootejärjekorda (faktiliselt varjupaigas)	2	1,0	2	1,4
sotsiaalmajutustee- nusele	20	9,5	20	14,4
hooldekodusse	7	3,3	7	5,0
psühhiaatrikliini- kuse, majutusega rehabilitatsiooniasu- tusse	2	1,0	2	1,4
elukohajärgsesse omavalitsusse teenusele	14	6,3	14	10,1
varjupaigas	56	26,5	56	40,3
surnud	15	7,1	15	10,8
koht teadmata	72	34,1	-	-
Kokku	211	100,0	139	100,0

ALLIKAS: TINT 2015

Tabel 4. Sotsiaaleluruumi taotlused

	Omaavalitsuses perioodi jooksul varjupaigateenust kasutanud isikud (2014. a oli oma- valitsuses kolm varjupaika)	Analüüsitavas varjupaigas teenusel viibi- nud isikud	Kokku sotsiaal- eluruumi avaldusi analüüsitavast asutusest (varju- paiga- ja sotsiaal- majutusteenuse klientidelt kokku)	sh võeti arvele	ei võetud arvele
> 2004	1740	...	18	14	4
2005–2009	1328	1032	19	14	5
2010–2014	1507	1013	21	14	7
Kokku	4575		58	42	16

ALLIKAS: TINT 2015; SOTSIAALMINISTEERIUM 2016A, 2016B.

järelduse: juhul kui kodutute rehabiliteerimise astmelise mudeliga võrreldes on teada tõhusamaid lahendusi, tuleks kaaluda nende kasutuselevõttu.

Kui kasutuses olevale andmestikule üldise klientuuri suuruse ja eluruumi taotluste kohta lisada info varjupaigast üürieluruumi kolinud isikute üürilepingute lõpetamisest, muutub pilt kriitilisemaks. Trepki kujundi kasutamise mõte on kirjeldada liikumist ülespoole. Umbes kolmest tuhandest 15 aasta jooksul varjupaika kasutanud isikust on samal perioodil sotsiaaleluruumi taotlenud 58, 42 on selle eralduse saanud, 25 üürilepingut on samal perioodil lõpetatud. Neist 25st ainult viiega lõpetati leping ülespoole liikumise põhjusel (ühel juhul on eraldatud tavaeluruum ja neljal juhul on isik kolinud talle sobivasse sotsiaaleluruumi, vt joonis 1, lk 50). Selline asjade seis sunnib kasutama mitte üles, vaid alla viiva trepki kujundit!

Praktikute teadmised kodutute resotsialiseerimise erinevatest mudelitest

Tulles tagasi kvalitatiivuuringu juurde (Käsk 2014), vaatame, millise hinnangu andsid eksperdid astmelise resotsialiseerimise mudelile,

milliste kriteeriumide alusel hinnatakse nende arvates kliendi võimekust iseseisvalt elamiseks, kui hästi nad tunnevad eluasemepõhist lähenemist ning milliseks peavad võimalusi rakendada seda lähenemist Eestis.

Hinnangud nii traditsioonilisele astmelise resotsialiseerimise mudelile kui ka innovaativsele eluasemepõhisele mudelile olid vastuolulised. Üks ekspertidest kirjeldas tänast seisust nii: „... astmelise rehabilitatsiooni mudel on nagu rulett”, see on õnnestumiste ja ebaõnnestumiste ahel, milles põhiteguriks on motivatsioon. Motivatsioon on suurem kodutuse perioodi alguses ja mida aeg edasi, seda väiksemaks see jääb. Teise asjatundja hinnangul on edu tõenäosem siis, kui isikule leitakse korter eluasemeturult. Tähtis on ka see, kas eluruum asub tavalises keskkonnas või mitmesuguste sotsiaalprobleemidega isikuid majutavas sotsiaalmajas. Viimasel juhul on tagasilanguse tõenäosus pinnale jäämisest suurem. Kõik kolm eksperti olid seisukohal, et iseseisvalt elamise (eluaseme) peamiseks motivaatoriks on vabadus ja sõltumatus: vabadus otsustada millal, mida ja kuidas teha, minimaalne väline sekkumine ja privaatsus. Praktikas on võimalik kliendi liikumine



ALLIKAS: TINT 2015

Joonis 1. Sotsiaaleluruumi taotlejad, selle saajad, „üles” ja „alla” liikujad varjupaiga klientuuris

varjupaigast sotsiaalkorterisse, jättes vahele siirdeeluaseme (sotsiaalmajutusüksuse) astme. Selline eluasemepõhine probleemilahendus on siiski erandlik.

Eelnevalt mainitud PPS-1 skaala hindab kodutu rehabiliteeritavust 11 tunnuse alusel. Ekspertide info kohaselt on praktika palju lihtsam: iseseisva eluaseme pakkumisel arvestatakse peamiselt kolme kriteeriumit „... oskus oma eelarvet (kulusid) kontrollida; oskus arvestada teiste inimestega (majanaabritega) ja töörealisel töo olemasolu”. Küsimusele alkoholisõltuvusest vastati üksmeelselt, et karskuse nõudmine on ebarealistlik. Kriteeriumiks on, et alkohol ei põhjustaks suuri probleeme isikule ja tema käitumise kaudu kaaskodanikele. Kaks intervjuueeritut tõdesid, et sotsiaalmajutusüksus ei ole tänases süsteemis siirdeeluse, vaid pikaajalise majutuse koht. Hinnanguliselt jääb sinna jõudnud isikutest 85% kliendiks kauemaks kui üheks, 50% kauemaks kui kaheks aastaks. Selline tulem on aga sõltuv nii indiviidist kui omavalitsusest. Sotsiaaleluruumide nappuse olukorras eelistatakse nende andmisel kodutule mõne

teise grupi (lastega pere, eakas abivajaja) esindajaid. Mujal maailmas on toimetulekuraskustega inimeste eluasemeprobleemi lahendamiseks võimalik avalike eluruumide kõrval kasutada nn sotsiaalsete üürileandjate (kirik, sotsiaalsuunitlusega fondid) omandit. Kui sellestki lisaressursist ei piisa, kasutatakse eluasemeturu sotsialiseerimise võtet⁶. Seetõttu on võimalik teha nii kliendi kui eluaseme omaniku vaatenurgast sobivaid valikuid.

Abstraktne teadmine eluasemepõhisest lähenemisest töös kodututega on spetsialistidel olemas, kuid kolmest intervjuueeritust oli vaid üks saanud sellega Soomes tutvuda. Tunnistades küll meetodi tõhusust, kahtles ta siiski selle juurutamises Eestis: „... kas on võimalik veenda otsustusõigust omavaid isikuid looma süsteemi, milles vähest ressurssi (sotsiaaleluruume) kulutatakse isikute tarbeks, kelle kohta on teada, et nad on lühikese aja jooksul võimelised selle „ära raiskama”?”. Tema kolleeg arvas, et keskkond mõjutab inimeste käitumist ja positiivne keskkonnamuutus toetab positiivset käitumist. Pidades silmas sihtgrupi domineerivaid probleeme

⁶ Kasumitaotluseta tegutsevate üürieluruumide vahendajate (ingl *Social Rental Agencies*) abi kasutamine, vt de Decker 2012.

(sõltuvus, psüühiline erivajadus), jäi ta aga lõppkokkuvõttes meetodi rakendatavuse suhtes kahtlevaks. Kõige optimistlikum ekspert tunnistas, et on sellisest võimalusest kogu aeg unistanud, kuid väitis, et kodutute teenusekorralduses peab olema kolm lüli: vastuvõtuüksus (varjupaik), iseseisva elamise üksus ja toetatud elamise üksus (institutsioon) neile, kes iseseisva eluga hakkama ei saa. Kõigi kolme eksperdi poolt sõltumatult välja öeldud seisukoht oli, et piiratud ressursside tingimustes ei sooviks nad eksperimenteerida esmapiigul riskantsena tunduva meetodiga, vaatamata sellele, et selle tulemuslikkus on mujal tõestatud (Käsk 2014, 38).

Kokkuvõte

Mitmed EL liikmesriigid on viimase kümne aasta jooksul koostanud kodutuse vastu võitlemise strateegiaid. Põhja-Ameerikas, Austraalias ja osas Euroopa riikides on rakendatud eluasemepõhiseid kodutute resotsialiseerimise süsteeme, mis toetuvad kahele põhimõttele: esiteks kiire omaette eluruumi leidmine raskustesse sattunud isikule; teiseks mõjus teenuste ja toetuste süsteem inimese sotsiaal-, tervise-, hõive- jm probleemide lahendamiseks.

Ka Eestis tuleks seada kindlad eesmärgid kodutuse probleemi lahendamiseks, sh üle vaadata praegune praktika töös kodututega. Nagu teistes sotsiaaltöö lõikudes, nii ka kodutute puhul peaks toimuma Mike Alleni poolt kirjeldatud nihe „eakate sotsiaaltöö mudelilt” ehk kliendi seisundi hoidmiselt „töötute sotsiaaltöö mudelile”, st kliendi seisundi muutmisele. Artiklis tutvustatud uurimuses selgus ekspertidega läbi viidud intervjuudest, et lühiajaliseks elupaigaks mõeldud varjupaik on praktikas pikaajalise majutuse koht. Pikaajaline viibimine ühe ja sama kliendigrupiga tegelevas teenusesüsteemis (Tallinna näide tööst kodututega) või

institutsioonis (Tartu, Pärnu jt linnade näide) ei stimuleeri inimeste liikumist toimetulekureppi mööda ülespoole. Kuigi võrreldes USA, Lääne-Euroopa ja meile lähedase Põhja-Euroopaga on Eesti kodutud homogeensem ja seega lihtsamalt rehabiliteeritav sihtgrupp (vähem psüühiliste ja narkoprobleemidega isikuid, valdavalt alkoholisõltuvusega inimesed), on meie sellesuunaline töö ebatõhus. Ühe konkreetse teenuseosutaja (varjupaiga) kliendiandmete analüüsi põhjal võib väita, et edasi liikumine toimub pigem institutsionaalset teed pidi ja teistes riikides suurimat sisulist tulemuslikkust andvate eluasemepõhiste lahenduste osatähtsus on väike: suurem osa varjupaiga teenust kasutanud klientidest, kelle elukäik oli teada, viibis aasta lõpu seisuga kas endiselt varjupaigas või oli edasi liikunud mõnda teise asutusse, nt sotsiaalmajutusüksusesse või hooldekodusse; vaid väike osa asus elama üüri- või sotsiaaleluruumi või oli taasühinenud oma perekonnaga.

Teises uurimuses osalenud ekspertidel on esmased teadmised eluasemepõhistest kodutuse tõrjumise mudelitest olemas. Üks intervjuueeritustest tunnistas, et ta on sellisest teenusekorraldusest unistanud. Teine, olles tutvunud Soome kogemustega, konstateeris, et mudel töötab. Kolmas intervjuueeritav oli nõus, et positiivne keskkonnamuutus toetab positiivset käitumist, kuid pidades silmas sihtgrupi domineerivaid probleeme, oli ta meetodi rakendatavuse suhtes kahtlev. Puudus usk, et nappivate ressursside (eluruumid, sotsiaaltöö personal, rahastamine) olukorras oleks ainult alt tuleva initsiatiiviga võimalik rakendada uusi lähenemisi. Silmas pidades kehtiva sotsiaalhoolekande seaduse (RT I, 30.12.2015, 5) § 3 punkt 2s sätestatud põhimõtet, et „abi andmisel lähtutakse abimeetme tulemuslikkusest, ...”

on aga vältimatu mitte ainult diskussioon praegu kodutute resotsialiseerimisel kasutatava lähenemise tulemuslikkuse üle, vaid ka reaalsed sammud selle asendamiseks mõne

tõhusama meetmega. Artiklis viidatud andmete põhjal võiks olla tõsiselt võetavaks alternatiiviks eluasemepõhine lähenemine kodutute rehabilitatsioonile. **S**

Viidatud allikad

- Allen, M.** (2012). Quality Standards in Homeless Services, Housing Led Approaches and the Legacy of „Less Eligibility”. *European Journal of Homelessness*, 6 (2), 159–166.
- Benjaminsen, L., Dyb, E.** (2008). The Effectiveness of Homeless Policies – Variations among the Scandinavian Countries. *European Journal of Homelessness*, 2, 45–67.
- Burrows, R.** (1997). The Social Distribution of the Experience of Homelessness. Teoses: Burrows, R., Pleace, N., Quilgars D. (toim.) Homelessness and Social Policy. London: Routledge, 50–68.
- Bush-Geertsema, V.** (2008). On the Way towards Normality. Housing and Support for Homeless People. Conference in Kolding.
- Busch-Geertsema, V.** (2011). Housing First Europe: A „social experimentation project”. *European Journal of Homelessness*, 5(2), 209–211.
- Bush-Geertsema, V.** (2013). Housing First Europe Final Report. Bremen: GISS Bremen. www.habitat.hu/files/FinalReportHousingFirstEurope.pdf (15.06.16).
- Bush-Geertsema, V., Benjaminsen, L., Filipovič Hrast, M., Pleace, N.** (2014). Extent and Profile of Homelessness in European Member States. A Statistical Update. EOH Comparative Studies on Homelessness, 4. Brüssel: European Federation of National Associations Working with the Homeless AISBL. www.feantsaresearch.org/IMG/pdf/feantsa-studies_04-web2.pdf (23.08.16).
- de Decker, P.** (2012). Social Rental Agencies: An Innovative Housing-led Response to Homelessness. Good Practice Briefing. Brüssel: FEANTSA. www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg=1088&cle=0a55d8c298835627b524457116802d1178edbbc5&file=pdf%2F2012_06_22_sra_final_en-2.pdf (15.06.16).
- Dobelniece, S.** (2007). Homelessness in Latvia: in the search of understanding. Doktoritöö. Tallinna Ülikool.
- Eesments, I.** (2010). Kodutus ja kodutud. *Sotsiaaltöö*, 4, 24–28.
- Euroopa kodutuse ja eluasemepuuduses isikute tüpoloogia ETHOS.** (2006). Brüssel: FEANTSA. www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg=219&cle=f7cc10e29f3ccd10c6b98f32198213e8064b3d7f&file=pdf%2Fee.pdf&lang=en (15.06.16).
- Euroopa 2020** (2010). Brüssel: Euroopa Komisjon. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ET:PDF> (23.01.16).
- Euroopa Komisjon** (2011). Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm: sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse Euroopa raamistik. Luxembourg: Euroopa Liidu Väljaannete Talitus. www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:167434 (15.06.16).
- Euroopa Parlamendi deklaratsioon tänavakodutuse kaotamise kohta.** (2006). www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0163+0+DOC+XML+V0//ET (31.10.16).
- Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi kodutuse kaotamise strateegia kohta.** (2011). www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0383+0+DOC+XML+V0//ET (31.10.16).
- Fitzpatrick, S., Pawson, H., Bramley, G., Wilcox, S., Watts, B.** (2016). The Homelessness Monitor 2011–2016. London: Crisis UK.
- Heaolu arengukava 2016–2023** (2016). Tallinn: Sotsiaalministeerium. www.sm.ee/et/heaolu-arengukava-2016-2023 (17.01.17).

- Houard, N.** (2011). The French Homelessness Strategy: Reforming Temporary Accommodation, and Access to Housing to Deliver „Housing First”: Continuum or Clean Break? *European Journal of Homelessness*, 5(2), 83–98.
- Institutsionaalselt hooldusmudelilt kogukonnapõhisele ülemineku Euroopa ekspertrühm.** (2012). Euroopa ühtsed juhised institutsionaalselt hoolduselt kogukonnapõhisele süsteemile ülemineku kohta.
- Integrated approaches to combating poverty and social exclusion. Best practices from EU Member States.** (2016). Haag: Ministry of Social Affairs and Employment.
- Johnsen, S.** (2012). Shifting the Balance of the Housing First Debate. *European Journal of Homelessness*, 6 (2), 193–199.
- Kõre, J.** (2003). Kodutus ja sotsiaaltöö – Eesti lahendused. *Sotsiaaltöö*, 1, 15–21.
- Kõre, J., Karpuskiene, V.** (2009). EU Social Inclusion Policy and the Progress of the Homeless Politics in Baltic States. Analysis of the National Action Plans of Social Inclusion 2004–2006, 2006–2008, 2008–2010. *Socialinė teorija, empirija, politika ir practica*, 5, 66–79.
- Kõre, J., Kiik, R., Boswinkel, E.** (2006). Homelessness in Estonia – Problem of the Individual or the Society? *European Journal of Housing Policy*, 6 (3), 297–312.
- Käsk, I.** (2014). Dealing with homeless: towards implementation of housing-led strategies in Estonia. Magistratöö. EELK Usuteaduse Instituut.
- Lewis, O.** (1966). The Culture of Poverty. *Scientific American* 215 (4), 19–25.
- Nelson, G., Patterson, M., Kirst, M., Macnaughton, E., Isaak, C., Nolin, D., McAll, C., Stergiopoulos, V., Townley, G., MacLeod, T., Piat, M., Goering, P.** (2015). Life Changes Among Homeless Persons With Mental Illness: A Longitudinal Study of Housing First and Usual Treatment. *Psychiatric Services*, 66 (6), 592–597.
- OECD.** (2015). Integrating Social Services for Vulnerable Groups. Bridging Sectors for Better Service Delivery. Pariis: OECD Publishing.
- Paavel, V.** (2003). Koduta inimeste hoolekanne Eestis. Käsiraamat. Tallinn: Tallinna Avahoolduse Arenduskeskus.
- Pleace, N.** (2011). The Ambiguities, Limits and Risks of Housing First from a European Perspective. *European Journal of Homelessness* 5 (2), 113–127.
- Pleace, N., Culhane, D., Granfelt, R., Knutagård, M.** (2015). The Finnish Homelessness Strategy. An International Review. Helsingi: Ministry of the Environment.
- Pöldemaa, K.** (2010). Kodutuid ei taheta enda ümber näha. *Sotsiaaltöö*, 4, 21–23.
- Raitakari, S., Juhila, K.** (2015). Housing First Literature: Different Orientations and Political-Practical Arguments. *European Journal of Homelessness*, 9 (1), 145–189.
- Sahlin, I.** (2005). The Staircase of Transition: Survival through Failure. *Innovation: The European Journal of Social Science Research*, 18 (2), 115–135.
- Sotsiaalhoolekande seadus.** (2015). *Riigi Teataja* I, 30.12.2015, 5.
- Sotsiaalministeerium** (2016a). Kodutute oomaja teenus / varjupaigateenus. Lühülevaated. 2011.–2015. aasta. www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Statistika/Sotsiaalvaldkond/Sotsiaalhoolekanne/kodutute_oomaja_teenus_2011-2015.docx (23.01.17).
- Sotsiaalministeerium** (2016b). Varjupaigateenus / turvakodu teenus. Lühülevaated. 2011.–2015. aasta. www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Statistika/Sotsiaalvaldkond/Sotsiaalhoolekanne/varjupaigateenus_2011-2015.docx (23.01.17).
- Statistikaamet** (2011). Rahva ja eluruumide loendus. Rahvastik eluruumi tüübi ja eluruumi kasutamise aluse, soo, vanuserühma ning elukoha järgi, 31. detsember 2011. Tabel RL0803. <http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/Saveshow.asp> (31.10.16).
- Swärd, H.** (1999). Homelessness in Sweden – discussion, patterns, and causes. *European Journal of Social Work*, 2 (3), 289–303.

- Tainio, H., Fredriksson, P.** (2009). The Finnish Homelessness Strategy: from a „Staircase” Model to a „Housing First” Approach to Tackling Long-term Homelessness. *European Journal of Homelessness*, 3, 181–199.
- Tallinna Sotsiaaltöö Keskus** (2012). Kodutud Tallinnas. Uuringu aruanne. Tallinn: Tallinna Sotsiaaltöö Keskus. www.swcenter.ee/site/data/10_kodutuuringuaruanne_1302.12_.pdf (15.06.16).
- Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse klientide rehabiliteeritavus. Uuringu kokkuvõte.** (2012). www.swcenter.ee/site/data/pps2kokkuvote2012_2802.13.pdf (15.06.16).
- Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse klientide rehabiliteeritavus. Uuringu kokkuvõte.** (2014). www.swcenter.ee/site/data/pps2kokkuvote_2014_0912.14.pdf (15.06.16).
- Talvoja, K.** (2007). Kodutute resotsialiseerimine (MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik ja Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse võrdlus). Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool.
- Tiit, E.-M.** (2013). Leibkonnad ja perekonnad. 2011 aasta rahva- ja eluruumide loendus. Pressikonverents 28.08.2013, PowerPoint ettekanne.
- Tint, E.** (2015). „Trepist üles või trepist alla” – varjupaigategenuse kasutajate resotsialiseerumise perspektiivid Tartu linna varjupaiga kodutute näitel. Bakalaureusetöö. Tartu Ülikool.
- Tsemberis S.** (2010). Housing first: Ending homelessness, promoting recovery, and reducing costs. Teoses: Ellen, I. G., O’Flaherty, B. (toim.) How To House the Homeless. New York: Russell Sage Foundation. 37–56.
- Tsemberis, S.** (2012). Housing First: Basic Tenets of the Definition Across Cultures. *European Journal of Homelessness*, 6 (2), 169–173.
- Tsemberis, S., Gulcur, L., Nakae, M.** (2004). Housing First, Consumer Choice, and Harm Reduction for Homeless Individuals with a Dual Diagnosis. *American Journal of Public Health*, 94(4), 651–656.
- TSK klientide rehabiliteeritavuse hindamine** (2010). www.swcenter.ee/site/data/ppskokkuvote_0504.10.pdf (15.06.16).
- Wagner, L., Korp, E., Walters, C.** (2014). Homelessness in Estonia: Overview and Analysis. *European Journal of Homelessness*, 8 (2), 231–244.

Autorid



Jüri Kõre



Ivo Kask



Eleanoora Tint

Jüri Kõre (geograafiakandidaat, inimgeograafia eriala, Peterburi ülikool) on Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi lektor. Aastatel 1996–1997, 1999–2001 ja 2010–2012 vastutas abilinnapeana sotsiaal- ja tervishoiuteenuste korralduse eest Tartu linnas. On FEANTSA (Euroopa organisatsioonide föderatsioon, kes tegelevad koduta jäänud inimestega) teadusnõunik (ingl *Research Advisor*).

Ivo Kask (usuteaduse magister, kõrvaleriala diakoonia, Usuteaduse Instituut) on Seitsmenda Päeva Adventistide Koguduste Eesti Liidu esimees. Aastatel 2006–2011 töötas MTÜ Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskuse Kuressaare varjupaiga juhina, pälvis 2010. a kodanikupäeva aumärgi.

Eleanoora Tint (sotsiaalteaduste bakalaureus, sotsiaaltöö eriala, Tartu Ülikool) töötab Tartu linnavalit-suses sotsiaaltöötajana, aastatel 2014–2016 olid tema sihtrühmaks koduta inimesed. Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö magistriõppe üliõpilane.

Abstract

The European Union has in last decades been focusing more than ever on the ability of its people to cope economically. In a resolution adopted in 2011, the European Parliament invited all Member States to compile strategies for fighting homelessness with the Housing First approach. The Housing First approach draws from the following principle: first housing, then rehabilitation, thereby differing decisively from the previous policies in developed countries. The approach is currently used in social work practices of North-America, Australia and several countries in Europe, and is implemented when dealing with the largest groups of homeless people such as single men with psychiatric disorders, alcohol and drug abuse problems etc.

This article seeks to answer the question whether it is justified to continue the work in Estonia in a traditional manner or it is necessary to introduce new solutions. For the sake of analysis, the article describes changes in trends of homelessness that have taken place in Estonia during the last decade, compares the strengths and weaknesses of the Staircase Rehabilitation Model and the Housing First approach, describes the performance outcomes of one traditional service provider and assessments given by Estonian experts to the Housing First approach. The authors conclude that more effective resocialization measures need to be implemented when working with homeless people in Estonia.